

延续性护理模式在压力性尿失禁患者盆底肌康复居家治疗中的应用效果

河南省濮阳市南乐县人民医院 (457400) 赵丽娜

摘要: **目的** 探讨在压力性尿失禁患者盆底肌康复居家治疗中实行延续性护理的临床效果。**方法** 选取我院压力性尿失禁患者70例作为研究对象,均采用盆底肌康复治疗,将其随机均分成两组,对照组采用常规护理,观察组采用延续性护理模式,比较两组临床效果。**结果** 观察组3~5级占68.6%,明显高于对照组34.3%,比较差异明显 ($P < 0.05$); 两组干预后观察组评分为 (1.75 ± 0.26) 分,明显低于对照组 (2.30 ± 0.37) 分,比较差异明显 ($P < 0.05$); 两组干预后尿失禁程度评分均低于本组干预前,比较差异明显 ($P < 0.05$)。**结论** 在压力性尿失禁患者盆底肌康复居家治疗中实行延续性护理临床效果良好,值得推广。

关键词: 延续性护理模式; 压力性尿失禁; 盆底肌康复; 居家治疗; 应用效果

中图分类号: R473.71 **文献标识码:** A

文章编号: 1005-8257 (2018) 04-0089-01

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2016年1月~12月收治的压力性尿失禁患者70例作为研究对象,均与国际尿失禁咨询委员会颁发的压力性尿失禁诊断标准相符;自愿参与本研究。将其随机分成两组,对照组 ($n=35$) 采用常规护理,观察组 ($n=35$) 采用延续性护理模式。对照组年龄为20~56岁,平均年龄为 (37.4 ± 8.4) 岁;观察组年龄为19~58岁,平均年龄为 (38.2 ± 8.9) 岁。两组基线资料比较无明显差异 ($P > 0.05$),具有均衡性。

1.2 护理方法 对照组在患者门诊时由护士指导锻炼盆底肌的方法,发放压力性尿失禁健康教育小册子,留下患者联系方式,叮嘱有异常症状便复诊。观察组采取延续性护理,具体如下:门诊时开展盆底肌康复锻炼指导,结合身体状况取坐位、卧位或站位以锻炼,每次20min,每天3次,每

次收缩时间超过3s,再放松,避免臀部与腿部肌肉参与。每天回院接受指导,直至掌握所有技巧可居家自行锻炼。排尿时若尿流减慢或停顿,还可开展间断排尿锻炼,在诱发尿失禁动作如咳嗽、弯腰时将盆底肌收缩,对不稳定膀胱收缩进行抑制,持续锻炼8周。发放健康教育小册子,内容包含压力性尿失禁概念、危害和诱因、便秘处理方法、辅助锻炼盆底肌的用具、避免摄取咖啡因等,留下患者微信号或QQ号,护士定期发布与压力性尿失禁与康复锻炼盆底肌的相关知识和方法,提升患者对本病的认知度。

1.3 观察指标 于干预前后应用国际尿失禁咨询委员会尿失禁问卷表 (ICI-Q-SF) 评估两组尿失禁程度,分数越高代表越严重。同时8周后测定两组盆底综合肌力,应用阴道肌电图肌电压联合手侧肌力法,测量盆底肌肉收缩持续时间与次数以测定盆底综合肌力,共1~5级,级别越高说明其恢复状况越好。

1.4 统计学方法 研究数据应用SPSS20.0处理, $n(\%)$ 表示计数资料,组间对比用卡方检验;标准差 ($\bar{x} \pm s$) 及均数 ($\pm$) 表示计量资料,组间对比用 t 检验, $P < 0.05$ 提示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组盆底肌综合肌力比较 见附表1。

2.2 两组干预前后尿失禁程度比较 见附表2。

3 讨论

正常状况下女性盆底支持系统完整,可对正常盆底功能予以维持,但妊娠与分娩期间均会损伤盆底功能,诱发压力性尿失禁、盆底肌肉松弛、盆腔器官脱垂等疾病。美国妇产科医生于上世纪40年代研究出凯格尔法以锻炼盆底肌肉功能,经过多年发展与实践后该方法不断完善,当前已经成为临床常用康复锻炼女性盆底功能

附表1 两组盆底肌综合肌力比较 [$n(\%)$]

组别	1~2级	3~5级
对照组 ($n=35$)	23 (65.7)	12 (34.3)
观察组 ($n=35$)	11 (31.4)	24 (68.6)
X^2	16.372	
P	<0.05	

附表2 两组干预前后尿失禁程度比较 ($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	干预前	干预后	t	P
对照组 ($n=35$)	2.69 ± 0.51	2.30 ± 0.37	3.915	<0.05
观察组 ($n=35$)	2.65 ± 0.46	1.75 ± 0.26	6.481	<0.05
t	0.418	5.007	-	-
P	>0.05	<0.05	-	-

障碍性疾病的主要方法。研究称节律性对盆底肌肌肉、肛门予以收缩可对其神经功能进行刺激,被动增加盆底肌肉及筋膜张力,恢复肌肉代偿作用^{[1][2]}。门诊或住院期间多指导产妇锻炼方法,多数要依靠患者自行居家锻炼。并且尿失禁为长期问题,若无专业指导、督促与患者依从性差的话,无法取得满意效果。传统医学模式中患者出院便不会享受到医疗服务。因此本院实施延续性护理,延伸院内服务至居家服务,发放健康宣教手册,门诊或院内细致指导,确保患者完全掌握盆底肌功能锻炼方法;并定期在微信或QQ等平台宣教疾病知识,便于护患及时沟通交流,提升患者认知度与依从性,使其坚持锻炼,进而减轻尿失禁症状及程度,增强盆底肌功能。

本组结果表明观察组3~5级占68.6%,明显高于对照组,且干预后观察组尿失禁评分明显低于对照组,由此可知,在压力性尿失禁患者盆底肌康复居家治疗中实行延续性护理临床效果良好,值得推广。

参考文献

- 1 刘京荣,胡斌,郑典宝,等.连续性护理干预对老年女性压力性尿失禁的影响[J].齐鲁护理杂志,2016,22(19):67~68
- 2 王轶,胡斌,郑典宝,等.压力性尿失禁患者的健康指导与护理干预[J].徐州医学院学报,2014,(7):487~488

(20170929收稿)